听力学及言语疾病杂志
Journal of Audiology and Speech Pathology
ISSN 1006-7299,CN 42-1391/R

《听力学及言语疾病杂志》网络首发论文

题目：　听力与言语康复专业本科生学习现状及影响因素研究
作者：　蒋雨歆，梁冰，黄治物，徐帅
收稿日期：　2024-11-28
网络首发日期：　2026-01-27
引用格式：　蒋雨歆，梁冰，黄治物，徐帅．听力与言语康复专业本科生学习现状及影响因素研究[J/OL]．听力学及言语疾病杂志.
https://link.cnki.net/urlid/42.1391.R.20260126.1016.031

网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

网络首发时间：2026-01-27 11:48:00　网络首发地址：https://link.cnki.net/urlid/42.1391.R.20260126.1016.031

·听力学教育·

听力与言语康复专业本科生学习现状及影响因素研究

蒋雨歆[1,2]　梁冰[1]　黄治物[1]　徐帅[1]

1　上海交通大学医学院附属第九人民医院耳鼻咽喉头颈外科，上海交通大学医学院医学技术学院听力与言语康复系，上海交通大学医学院耳科学研究所，上海市耳鼻疾病转化医学重点实验室（上海　200011）；　2　上海中医药大学康复医学院（上海　201203）

通信作者：徐帅（Email：xus028@163.com）

基金项目：上海交通大学医学院附属第九人民医院院级教学课题（JYJX03202405）、上海交通大学医学院实验实践教学研究（DG-2024-28）、上海交通大学医学院高水平地方高校专项（BJ1-7000-24-7221）推进“卓越医学创新人才培养”体系建设

【摘要】　目的　调查国内听力与言语康复专业本科生学习现状，并分析其影响因素。**方法**　对国内开设听力与言语康复专业院校的在校本科生开展问卷调查，采用线上填写的方式收集相关基本信息并填写学习投入量表。共采集 573 名学生的有效数据并分析，其中大一 138 人（24.08%），大二 185 人（32.29%），大三 144 人（25.13%），大四 106 人（18.50%）。分析人口学特征、自身人格特征、社会支持环境对其学习投入的影响。**结果**　①573 名听力与言语康复专业本科生学习投入得分为80.71±17.01分，呈中等水平，中等及以上水平者占67.02%（384/573）；②该专业本科生随年级升高学习投入得分降低，大一得分最高，为84.90±17.24分，与其他年级有显著差异（$P<0.01$）；③担任学生干部者学习投入得分为83.53±16.54分，显著高于非学生干部（79.13±17.09分）（$P<0.01$）；④明确听力或言语专业偏向者学习投入得分分别为83.76±16.45和80.39±16.36分，显著高于未明确偏向者（77.35±17.96分）（$P<0.01$）。**结论**　听力与言语康复专业本科生学习投入总体呈中等水平，年级、专业偏向和学生干部是其影响因素。开设该专业的院校可基于学习动机、精力及专注三个维度，通过持续激发学习动力、指导明确专业偏向以及发挥学生干部优势，来帮助学生提高学习投入水平。

【关键词】　听力与言语康复专业；　本科生；　学习投入

Study on the current situation and the related influencing factors of learning engagement of undergraduate students majoring in hearing and speech rehabilitation

JIANG Yuxin[1,2], LIANG Bing[1], HUANG Zhiwu[1], XU Shuai[1]

1 Department of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery, Shanghai Ninth People's Hospital, Shanghai Jiaotong University School of Medicine; Department of Hearing and Speech Rehabilitation, College of Health Science and Technology, Shanghai Jiaotong University School of Medicine; Shanghai Jiaotong University School of Medicine Ear Institute, Shanghai Key Laboratory of Translational Medicine for Ear and Nose Diseases, Shanghai 200011, China; 2 School of Rehabilitation Science, Shanghai University of Traditional Chinese Medicine, Shanghai 201203, China

Corresponding author: XU Shuai (Email: xus028@163.com)

听力与言语康复专业是一门从临床实际出发，研究听觉生理、病理以及听力言语康复方法的综合性学科[1,2]，致力于培养能够从事听力诊断、康复及相关健康服务的专业人才[3]。

学习投入（learning engagement）是衡量学生在学业过程中积极性和投入程度的重要指标，直接反映学生的学习现状。学习投入涉及动机、精力和专注三个方面[4]，即学生积极参与各项学习活动，以饱满的热情和精力应对各项挑战和挫折。SCHAUFELI 等最早提出学习投入的概念，并开发了乌特勒支工作投入量表-学生版（Utrecht work engagement scale-student，UWES-S）来测量学生的学习投入水平。学习投入会直接影响学生的专业学习、专业能力及未来的职业发展[5]。在面对学业挑战时，学习投入越高的学生表现出越强的韧性和动力，从而提高学习质量。目前学习投入已在护理学[6]和特殊教育学[7]等医学相关专业中得到广泛研究，尚无专门针对听力与言语康复专业本科生的系统研究。该专业的专业特性更强，且公众认知度低，可能进一步影响学生的学习投入水平，有待深入研究。

学习投入的影响因素可归纳为人口学特征、自身人格特征（内在因素）和社会支持环境（外在因素）三类[8,9]。本研究试图从这几方面了解听力

与言语康复专业本科生的学习投入现状，并探究其可能的影响因素，从内在需求与外部环境交互的角度，解释学习投入的个体差异。旨在为该专业本科教育提供优化思路，以提高本专业学生的学习投入水平，进而提高学生的学业水平和专业能力，提升专业竞争力。

1 资料与方法

1.1 研究对象 本研究通过线上问卷的方式，于2024 年 10 月至 11 月向上海中医药大学、华东师范大学、上海交通大学等 10 所院校的听力与言语康复专业在读学生发放问卷 650 份，收到 582 份填写问卷，对收回的问卷进行复核与检查，最终确定有效问卷 573 份，有效率为 98.45%。其中男 182 人(31.76%)，女 391 人(68.24%)；大一 138 人(24.08%)，大二 185 人(32.29%)，大三 144 人(25.13%)，大四 106 人(18.50%)。本研究通过上海交通大学医学院附属第九人民医院转化医学伦理审查专委会审批(2025-T112)。

1.2 评估方法

1.2.1 一般信息收集 收集学生以下信息：①人口学特征：性别、年级(大一至大四)、生源地(城镇或农村)、家庭医学背景(是否有家庭成员从事医学相关职业)；②自身人格特征：专业偏向(听力或言语或未明确方向)、调剂情况(调剂或未调剂)、参加本专业志愿者情况(是否有本专业相关志愿者服务经历)；③社会支持环境：是否担任学生干部、临床接触情况(实习或见习或未接触)。

1.2.2 学习投入量表 UWES-S 评估 采用 UWES-S 中文修编版[10]。量表共 17 个条目，包括动机(6 个条目)、精力(6 个条目)、专注(5 个条目)三个维度。按照发生频率从“从来没有”到“总是”分别记为 1～7 分，总分 119 分。分数越高，表示学习投入水平越高。分级标准如下[11]：得分 17～48 分(≤总分的 40%)学习投入为低水平；49～71 分(总分的 40%～≤60%)为中低水平；72～95 分(总分的 60%～≤80%)为中等水平；96～119 分(>总分的 80%)为高水平。该量表的 Cronbach's α 系数在 0.88～0.92 之间，信度良好；结构效度已得到验证[12]，适用于当前研究对象。

1.3 统计学方法 采用 SPSS 25.0软件对所得数据进行统计分析，对受试者一般资料进行描述性统计，计算均值、标准差，呈正态分布的计量资料以 $\bar{x}\pm s$ 表示。对于两组样本均值的比较(性别、学生干部、调剂情况、生源地、家庭医学背景、参加专业相关志愿者)采用独立样本 t 检验；对于三组及以上样本均值的比较(年级、专业偏向、接触临床情况)采用单因素方差分析 ANOVA，并使用 SNK-q 检验进行多重比较。学习投入总分与各维度得分数据为连续变量且服从正态分布，采用 Pearson 相关性分析。所有统计检验均采用双侧检验，$P<0.05$为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 UWES-S 量表得分情况 573 名听力与言语康复专业本科生学习投入总分为80.71±17.01分，总体处于中等水平。根据标准划分学习投入水平，其中低水平 10 例(1.75%)得分为33.70±11.36分；中低水平 179 例(31.24%)得分为65.49±5.23分；中等水平 281 例(49.04%)得分为81.94±5.76分；高水平 103 例(17.98%)得分为108.40±8.45分。其中动机维度得分最高，为29.45±6.09(6～42)分，其次是专注维度23.79±3.68(5～35)分，精力维度得分最低，为27.47±6.18(6～42)分。

2.2 学习投入水平的单因素分析 573 例学生 UWES-S 量表总分及各维度得分见表 1、2。

表 1 573 例听力与言语康复专业本科生学习投入的单因素分析

项目	例数/例	UMES-S 量表得分/分	t/F 值	P 值
性别				
男	182	81.35±18.93	1.195	0.407
女	391	79.75±16.03		
年级				
大一	138	84.90±17.24	4.17	0.006
大二	185	80.49±15.60		
大三	144	79.31±16.50		
大四	106	77.02±18.62		
学生干部				
是	206	83.53±16.54	2.99	0.003
否	367	79.13±17.09		
调剂				
调剂	242	80.63±16.81	−0.142	0.887
未调剂	331	80.83±17.32		
生源地				
城镇	247	81.08±18.20	0.452	0.652
农村	326	80.43±15.17		
家庭医学背景				
是	112	79.84±18.43	−0.605	0.545
否	461	80.92±16.39		
专业偏向				
听力	199	83.76±16.45	6.487	0.002
言语	160	80.39±16.36		
未明确	214	77.35±17.96		
接触临床				
实习	113	79.27±18.02	1.46	0.233
见习	236	79.98±16.47		
未接触	224	82.22±17.27		
参加本专业志愿者				
是	273	81.46±17.01	1.006	0.315
否	300	80.03±17.02		

从表 1 可见，大一～大四的学习投入均分随年级增长逐步下降，大一学生的学习投入得分与其他年级有显著差异（$P<0.01$），而其余年级之间虽随着年级增长得分有所下降，但无显著差异（$P>0.05$）。未明确专业偏向学生的学习投入得分均低于已选择听力或言语方向者，担任学生干部者的学习投入得分高于非学生干部者，差异均有统计学意义（$P<0.01$）。是否有家庭医学背景、是否接触临床、是否参加本专业志愿者之间学习投入得分差异均无统计学意义（$P>0.05$）。

从表 2 可见，大一学生在动机、精力及专注三个维度得分与其他年级均有显著差异（$P<0.01$）。未明确专业偏向学生的各维度得分均显著低于已选择听力或言语方向者（$P<0.01$），相较于精力维度得分差异（$P<0.05$），动机和专注维度得分差异更显著（$P<0.01$）。担任学生干部者各维度得分显著高于非学生干部，动机和精力维度的得分差异更显著（$P<0.01$）。

2.3　相关性分析　表 3 显示，学习投入总分与各维度得分之间均呈显著正相关（$P<0.01$）。

表 2　573 名听力与言语康复专业本科生学习投入各维度得分单因素分析

项目	动机维度得分/分	t/F 值	P 值	精力维度得分/分	t/F 值	P 值	专注维度得分/分	t/F 值	P 值
性别									
男	29.62±6.84	0.43	0.661	28.14±6.78	1.77	0.077	24.20±5.88	1.27	0.204
女	29.38±5.71			27.16±5.86			23.60±4.97		
年级									
大一	30.91±6.18	4.06	0.005	28.63±6.35	3.87	0.009	25.05±5.19	3.83	0.010
大二	29.44±5.70			27.35±5.57			23.36±5.08		
大三	28.92±5.96			27.02±6.00			23.70±4.97		
大四	28.49±6.41			26.49±6.76			23.04±5.91		
学生干部									
是	30.63±5.93	3.49	0.001	28.40±6.09	2.71	0.007	24.50±5.16	2.43	0.015
否	28.79±6.08			26.95±6.18			23.39±5.31		
调剂									
调剂	29.40±6.08	0.26	0.796	27.50±6.07	0.13	0.900	23.73±5.25	0.31	0.758
未调剂	29.53±6.11			27.43±6.34			23.87±5.34		
生源地									
城镇	29.70±6.69	0.85	0.396	27.57±6.95	0.33	0.739	23.81±5.97	0.09	0.933
农村	29.26±5.60			27.39±5.53			23.78±4.70		
家庭医学背景									
是	29.24±7.06	−0.41	0.683	27.07±7.07	−0.76	0.450	23.53±5.93	−0.59	0.553
否	29.50±5.83			27.56±5.95			23.86±5.11		
专业偏向									
听力	30.56±5.96	7.14	0.001	28.02±5.97	4.75	0.011	24.78±5.13	6.68	0.001
言语	29.40±5.92			27.36±6.04			23.63±4.97		
未明确	28.14±6.23			26.63±6.47			22.78±5.67		
接触临床									
实习	28.88±6.37	1.16	0.313	26.99±6.43	1.51	0.223	23.45±5.77	1.60	0.203
见习	29.32±5.84			27.19±6.01			23.47±5.14		
未接触	29.92±6.28			28.02±6.29			24.29±5.22		
参加志愿者									
是	29.72±6.14	1.01	0.312	27.63±6.13	0.61	0.540	24.11±5.32	1.36	0.175
否	29.21±6.04			27.32±6.22			23.51±5.24		

表 3　573 例听力与言语康复专业本科生学习投入总分及各维度得分相关性分析

总分及维度	总分	动机维度	精力维度	专注维度
总分	1.000			
动机维度	0.950①	1.000		
精力维度	0.946①	0.836①	1.000	
专注维度	0.968①	0.908①	0.898①	1.000

注：①$P<0.01$。

3　讨论

3.1　听力与言语康复专业本科生学习投入总体呈中等水平　本研究结果显示，听力与言语康复专业本科生学习投入得分总体呈中等水平，与以往其他小众专业（如特殊教育）的研究结果较为一致[5,11,13]。尽管总体数据表明大部分学生对学习持积极态度，但仍有约 33%的学生学习投入处于中低

水平或低水平，显示出当前教学模式在激发学生学习投入方面仍有优化空间。进一步分析学习投入的三个维度，发现动机维度得分最高，动机维度主要反映学生对于学习的态度和观念，表明学生普遍认可本专业的价值，并愿意投入时间和精力进行学习。然而专注、精力维度的得分偏低，可能与外部环境相关，即学生缺乏持续支持性的学习环境以及有效的学习策略，反映出本专业教师在学风建设方面，对于学生的正向引导及支持度不够。值得注意的是，本研究还发现三个维度及总分之间存在显著正相关关系（$P<0.01$），表明如果学生具备较强的学习动机，则学习投入水平变高；但若学习精力和专注度不足，将削弱其学习信心，对整体学业表现产生负面影响。

3.2 人口学特征对学习投入的影响 既往研究认为女性似乎比男性具有更高的学习动机与参与，关于年龄因素尚无明确定论[8]，仅部分研究认为高年级的学生表现更好，家庭所在地[14]也与学习投入相关。本研究结果显示，在人口学特征中学习投入仅在不同年级之间存在显著差异，在性别、家庭医学背景、生源地之间的差异并不显著，与槐福乐等[15]的结果较为一致。在年级方面，听力与言语康复专业本科生的学习投入水平随年级增长呈下降趋势，其中大一学生的得分显著高于其他年级（$P<0.01$），且在动机维度得分差异更显著（$P<0.01$）。这一现象可以从学习动机的角度来解释，已有研究表明动机对学习投入有较高的解释力[15,16]。根据 DECI 于 2000 年提出的自我决定理论（self-determination theory，SDT）可知，个体行为动机取决于三大基本心理需求的满足，即自主性、胜任感和归属感，其中胜任感指的是个体对自身能力的积极认知，当学生感到自己能够胜任学习任务时，更容易保持较高的学习投入。

在低年级阶段，听力与言语康复专业的课程以基础公共课为主[17]，大部分学生依托自身知识储备能较顺利掌握，即满足胜任感。该过程可通过 SDT 的子理论——认知评价理论（cognitive evaluation theory，CET）来进一步解释[18]：学生通过学习成果不断获得正向反馈，较高的胜任感能提高学习动机，促使他们保持学习积极性。然而随着年级升高，课程与临床实践结合占比加大，加之部分院校采取末位淘汰制度，使得学生面临更大的学业挑战。此外，听力与言语康复专业的职业定位尚不明确[19,20]，使得许多专业人才不愿意选择本专业就业[21]。学业与职业不确定性的双重压力，使得高年级学生面临更多失败经历，胜任感需求进一步受挫[18]。因此，随着年级升高听力与言语康复专业本科生的学习投入逐渐降低，主要是因为上述情况负向反馈削弱了学习动机，从而影响学业成果。如何在高年级阶段持续激发学生的学习动机，维持较高的学习投入水平，值得进一步探讨。

3.3 自身人格特征对学习投入的影响 本研究结果显示，在自身人格特征中调剂情况和参加本专业相关志愿者不对学习投入产生显著影响，而明确专业偏向学生的学习投入水平显著高于未明确者（$P<0.01$），尤其在动机和专注维度得分差异更显著（$P<0.01$）。这与 KUSURKAR 的研究结论相符，即自主选择专业的学生往往具备更有效的学习策略，并对成绩产生积极的间接影响。该现象可以从两个角度进行解释，首先从自我决定理论来看，明确专业偏向是学生内在自主性的体现[8]。这类学生通常将专业学习视为个人兴趣与价值的体现，而非被动完成任务，意味着他们能够感到自我主导，满足了 SDT 框架中的自主性需求，从而维持良好的学习动机。其次，基于 MARK 提出的职业生涯建构理论（career construction theory，CCT），明确专业偏向标志着学生已完成职业适应的关键阶段[22]。这种明确性带来两方面优势：①形成清晰的职业发展规划，无论是继续升学还是从事本专业相关工作，他们对于本专业有更多认同感，能正向预测学习投入[23]；②减少职业探索中的资源损耗，使学生能将有限精力集中投入到专业学习，从而保持高水平的专注度。相较而言，未明确专业偏向者不仅对自身的职业规划不明确，甚至不愿意在未来从事相关职业。他们将学业视为短期任务，缺乏学习专注度，反过来影响学习动机，导致整体学习投入水平相对较低。

3.4 社会支持环境对学习投入的影响 本研究结果显示，在社会支持环境中接触临床情况对学生学习投入影响不大，但担任学生干部者的学习投入水平高于非学生干部者（$P<0.01$），这与以往研究结论一致[15,24]，并且动机和精力维度的得分差异更显著（$P<0.01$）。一方面，学生干部在自信、精力和韧性等方面显著高于其他学生[24,25]，他们拥有平衡学业与工作的综合能力，帮助他们在面对学习挑战时抵抗压力，将持续的精力投入学习任务中。另一方面，由于角色定位，学生干部能够建立更广泛的社会联系，包括与同学、教师和社会的联结[26]。个体所处的社会网络及其所能获取的资源，对个体的发展起着重要作用。基于 SDT 框架，这些广泛的联系提供了学业资源（如更多学习机会、指导与推荐）和社会支持，促进他们获得更强的胜任感，从而提升学习动机。

3.5　听力与言语康复本科生学习投入现状的改进建议　基于以上结果，听力与言语康复专业本科生的学习投入不足，可通过优化教学来改善这一问题，提出以下几点针对性建议：

3.5.1　持续激发学习动机，获得胜任感　听力与言语康复专业教师可以提升课程的趣味性和互动性，激发学生的学习动机。比如，在教学中根据每个学生的具体需求和能力水平，设计个性化且具有挑战性的案例分析、动画拍摄等任务。同时提供及时正反馈，帮助学生逐步提升学习胜任感，激发内在学习动机，提升整体学习投入。

3.5.2　尽早明确专业偏向，指导学业规划　在自身人格特征中，明确专业方向对学习投入影响最大。听力与言语康复专业划分为听力和言语两个方向，课程的内容有很大差别。因此，院校应鼓励学生入学后就进行学业规划，尽量在大二阶段就明确专业偏向，对于分配选修课的比重有很大帮助。既往研究表明，有学业规划的学生学习投入水平更高[15,27]。一方面，可通过设立导师制给每位学生提供个性化的学业咨询和规划，帮助学生对于不同方向有清晰认识并建立阶段目标。另一方面，可邀请毕业校友分享自身从业经验，让学生更清楚地了解该领域的职业路径及其社会贡献，增强他们的归属感和专业认同，构建自己的职业生涯规划。

3.5.3　提供外部支持，发挥学生干部模范性　在社会支持环境中，担任学生干部对学生的学习投入产生了影响。由于学生干部具有较强的综合能力，学校可以根据这一特性制定“以好带弱”的小组模式，让学生干部作为组长带领其他同学共同学习，组织高效的学习讨论和资源共享，帮助同学们弥补学习上的不足，尤其是对于学业困难的学生，可以激发他们的学习兴趣和动力。

4　参考文献

[1]　普通高等学校本科专业目录(2020 年版)[J]. 考试与招生，2022(Z1)2022(5)：60-75.

[2]　陈颖，延江健，吴斯莹，等. 我国听力与言语康复学专业本科教育理论学习及实习现状调查[J]. 中国听力语言康复科学杂志，2023，21(5)：541-544.

[3]　王丽芳，李强，王震. 中英听力与言语康复学专业人才培养现状浅析[J]. 听力学及言语疾病杂志，2018，26(4)：427-430.

[4]　WANG M T，DEGOL J. Staying engaged：knowledge and research needs in student engagement[J]. Child Dev Perspect，2014，8(3)：137-143.

[5]　冯颖. 大学生学习投入影响因素及其提升策略[J]. 科技风，2024，(25)：163-165.

[6]　王维，朱唯一，陈燕，等. 5E 临床教学模式对实习护生学习投入及学习成效影响的实证研究[J]. 军事护理，2025，42(3)：108-112.

[7]　陈奕荣，吴忠良. 特殊教育师范生感知班级氛围对学习投入的影响：专业认同的中介作用与未来取向的调节作用[J]. 心理发展与教育，2022，38(2)：244-253.

[8]　ORSINI C，BINNIE V I，WILSON S L. Determinants and outcomes of motivation in health professions education：a systematic review based on self-determination theory[J]. J Educ Eval Health Prof，2016，13：19.

[9]　袁煜琦，黄睿彦. 基于多种分析方法的国内大学生学习投入研究综述[J]. 江苏经贸职业技术学院学报，2022，(3)：51-55.

[10]　刘正宗，章新月，柳进，等. 父母积极教养方式对大学生学习投入的影响：未来自我连续性和自我控制的中介作用[J]. 中国临床心理学杂志，2025，33(1)：76-81.

[11]　高勤，夏婷婷，陈颖. 专升本护生学习投入现状及其与自我价值感的关系[J]. 卫生职业教育，2024，42(18)：62-65.

[12]　邓旭阳，刘晓刚，刘取芝，等. 父母心理控制与大学生学习投入及负性情绪的关系：挫败感和应对效能的链式中介作用[J]. 中国临床心理学杂志，2023，31(1)：142-147，126.

[13]　冷晴，范莉莉，王昕媛. 特殊教育专业本科生学习现状的调查研究及改进建议—以甘肃省某高校为例[J]. 黑龙江教师发展学院学报，2024，43(8)：60-63.

[14]　袁煜琦，黄睿彦. 学习投入度视角下医学生类型划分及分布研究[J]. 现代医学，2022，50(S1)：20-25.

[15]　槐福乐. 应用型本科院校工科大学生学习投入现状、差异及其影响因素—基于13 976份样本数据的分析[J]. 高教探索，2024，(2)：56-63.

[16]　KANG X，HU D，WU Y，et al. Evaluating academic motivation among Chinese secondary EFL learners：validation and measurement invariance[J]. BMC Psychol，2025，13(1)：235-235.

[17]　刘建菊，万萍，金星，等. 上海中医药大学听力与言语康复学专业简介[J]. 听力学及言语疾病杂志，2017，25(6)：648-650.

[18]　LEE S J，JEONG E J，KIM D J，et al. The influence of psychological needs and motivation on game cheating：insights from self-determination theory[J]. Front Psychol，2023，14：1278738.

[19]　梁胜祥，张清清，陈晓华，等. 新医科背景下听力与言语康复学专业本科生科研创新能力培养模式探索[J]. 创新创业理论研究与实践，2023，6(4)：149-152，183.

[20]　丁伶萍，孟照莉，郑芸. 浅谈听力技师规范化培训管理实践与体会[J]. 听力学及言语疾病杂志，2020，28(1)：78-80.

[21]　家博，苏金星，田友丽，等. 领悟社会支持对感知就业能力的影响：有调节的中介效应[J]. 中国健康心理学杂志，2024，32(7)：1058-1064.

[22]　YANG L，SIN K F，SAVICKAS M L. Assessing factor structure and reliability of the career adaptability scale in students with special educational needs[J]. Front Psychol，2023，14：1030218.

[23]　郭磊，贾秀芬，刘涛. 高等职业学校康复治疗技术专业学生的专业认同感、学习动机和学习投入度的关系[J]. 中国

康复理论与实践，2022，28(9)：1110-1116.

[24] 魏星，许舒雯. 理工类高校学生干部与非学生干部学习性投入差异比较分析[J]. 学校党建与思想教育，2016，(15)：89-91.

[25] 童雪央. 高质量发展视域下高职学生心理资本积极支持系统构建[J]. 职业技术教育，2023，44(32)：38-42.

[26] 刘林艳，李茜，荀琳，等. 大学生领悟社会支持与其生涯适应力的关系:核心自我评价的中介作用[J]. 心理月刊，2023，18(21)：76-79.

[27] 顾金媛，谢亮，戴晗，等. 应用型医学类院校本科生学习投入影响因素研究—以南京医科大学康达学院为例[J]. 科技风，2024，(24)：148-150.

(2024-11-28 收稿)